

Papanicolaou y test de VPH

1. Introducción y relevancia clínica

El **Papanicolaou (PAP)** y el **test del Virus del Papiloma Humano (VPH)** son las **herramientas principales para la detección precoz del cáncer cervicouterino (CCU)**, una enfermedad prevenible y curable si se diagnostica en etapas tempranas.

En Chile, ambos forman parte del **Programa Nacional de Cáncer Cervicouterino del MINSAL**, cuyo objetivo es **reducir la mortalidad por cáncer de cuello uterino en un 25% al año 2030**, alineado con las metas de la **OMS**.

- En EUNACOM, las preguntas más frecuentes incluyen:
 - Indicaciones y edad de inicio del PAP.
 - Intervalos de tamizaje según edad y resultados.
 - Conducta ante citología anormal (ASC-US, LSIL, HSIL).
 - Comparación entre test VPH y PAP.
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

El cáncer cervicouterino se desarrolla a partir de **lesiones intraepiteliales** causadas por la infección persistente del **Virus del Papiloma Humano (VPH)**, principalmente tipos 16 y 18.

Estas lesiones progresan lentamente:

1. Infección VPH →
2. Neoplasia intraepitelial cervical (NIC I–III) →
3. Carcinoma in situ →
4. Cáncer invasor.

Dado que esta progresión tarda entre **10 y 15 años**, el tamizaje periódico permite **detectar y tratar lesiones antes de que se vuelvan invasoras**.

3. Métodos de tamizaje

a.

Papanicolaou (citología cervical)

Concepto

Prueba citológica que identifica **alteraciones morfológicas celulares** compatibles con displasia o malignidad.

Procedimiento

1. Recolección de células del **epitelio escamoso y glandular** del cuello uterino.
2. Fijación en lámina (convencional) o medio líquido.
3. Lectura microscópica según **sistema Bethesda**.

Condiciones ideales

- No realizar durante menstruación.
 - Evitar relaciones sexuales, duchas vaginales y óvulos 48 h previas.
 - Toma ideal en zona de transformación (unión escamocolumnar).
-

b.

Test de VPH

Concepto

Prueba molecular que **detecta ADN o ARN del VPH de alto riesgo oncogénico** (tipos 16, 18, 31, 33, 45, etc.).

Ventajas

- Mayor sensibilidad ($\approx 95\%$).
- Permite intervalos de tamizaje más amplios (5 años).
- Detecta infección antes de la aparición de alteraciones citológicas.

Desventajas

- Menor especificidad (detecta infecciones transitorias).
- Requiere confirmación con colposcopía o PAP en casos positivos.

4. Población objetivo y periodicidad (según MINSAL 2023)

Grupo	Método principal	Frecuencia
Mujeres 25–64 años	PAP	Cada 3 años (si 2 normales consecutivos)
Mujeres 30–64 años	Test VPH (ADN/ARN)	Cada 5 años si negativo
Mujeres >65 años	Suspender si 2 tamizajes normales previos	
Mujeres inmunosuprimidas (VIH, trasplantes)	PAP anual desde inicio de actividad sexual	

☐ En EUNACOM: “El PAP se inicia a los 25 años y se repite cada 3 años si es normal.”

5. Sistema Bethesda (2014) – Clasificación citológica

Categoría	Descripción	Conducta recomendada
Negativo para lesión intraepitelial o malignidad	Normal	Control según edad

ASC-US	Células escamosas atípicas de significado incierto	Repetir PAP en 12 meses o test VPH
ASC-H	Células atípicas, no se puede descartar HSIL	Colposcopia inmediata
LSIL	Lesión escamosa de bajo grado (NIC I)	Colposcopia
HSIL	Lesión escamosa de alto grado (NIC II–III)	Colposcopia + biopsia o conización
AGC / Adenocarcinoma in situ	Células glandulares anormales	Estudio colposcópico y canal endocervical

6. Manejo según resultado (según MINSAL 2023)

Resultado	Conducta
PAP normal	Control según intervalo (3 años o 5 años con VPH negativo)
ASC-US	Repetir PAP o test VPH: si VPH positivo → colposcopia
LSIL	Colposcopia inmediata
HSIL o sospecha de cáncer	Colposcopia + biopsia / derivar a especialista

Lesión glandular o adenocarcinoma

Colposcopía + legrado endocervical y biopsia

VPH positivo con citología normal

Colposcopía o repetir test en 12 meses

En mujeres menores de 30 años, las infecciones por VPH suelen ser **transitorias**, por lo que se recomienda observación inicial si no hay lesión citológica significativa.

7. Colposcopía y biopsia cervical

a.

Colposcopía

- Método diagnóstico complementario que **visualiza la zona de transformación del cuello uterino** con ácido acético (3–5%) o lugol.
- Permite dirigir biopsias a zonas sospechosas.

Hallazgos típicos:

- **Epitelio acetoblanco:** lesión epitelial.
- **Punteado / mosaico:** displasia moderada.
- **Vasos atípicos:** sospecha de invasión.

b.

Biopsia

- Confirma grado de displasia (NIC I, II, III).
 - Define conducta terapéutica.
-

8. Conización cervical

Indicaciones:

- Lesión de alto grado (HSIL / NIC II–III).
- Discordancia entre citología, colposcopia y biopsia.
- Margen positivo tras tratamiento previo.

Técnicas:

- LEEP (electrocirugía), bisturí frío o láser.

Permite diagnóstico histológico definitivo y tratamiento local curativo.

9. Comparación entre PAP y Test de VPH

Característica	Papanicolaou	Test VPH
Detecta	Alteraciones celulares	ADN/ARN viral
Sensibilidad	60–70%	90–95%
Especificidad	Alta	Moderada
Edad inicio	25 años	30 años
Frecuencia	Cada 3 años	Cada 5 años
Utilidad	Lesiones presentes	Riesgo futuro
Resultado positivo	Lesión actual	Infección (puede no progresar)

☐ Estrategia combinada (“co-test”) = máxima seguridad, útil en mujeres >30 años.

10. Factores que afectan los resultados del PAP

- Menstruación o sangrado vaginal.
- Relación sexual reciente.
- Duchas vaginales u óvulos.
- Toma fuera de la zona de transformación.
- Infecciones o inflamación cervical.
- Lectura citológica deficiente.

Un PAP mal tomado puede dar **falsos negativos** hasta en un 10–20% de los casos.

11. Importancia del seguimiento

El **seguimiento adecuado** de las pacientes con PAP o test anormal es **clave para la detección precoz del cáncer cervicouterino**.

Recomendaciones:

- Notificar y registrar resultados en ficha y sistema informático.
 - Asegurar colposcopia o derivación según nivel de atención.
 - Documentar tratamiento y evolución.
 - Reforzar educación y adherencia al control.
-

12. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

☐

Perlas

1. El **PAP detecta displasias**; el **test VPH detecta infección**.
2. Iniciar tamizaje a los **25 años**, cada **3 años** si normal.
3. **ASC-US**: repetir PAP o hacer test VPH.
4. **LSIL o HSIL**: derivar a colposcopía.
5. **VPH positivo** → **colposcopía inmediata**.
6. **Co-test** (PAP + VPH) cada **5 años** si ambos negativos.
7. La **zona de transformación** es el sitio clave para el muestreo.
8. El **PAP normal no excluye infección por VPH** ni otras ITS.



Errores comunes

- Realizar PAP antes de los 25 años sin indicación.
- Repetir PAP antes de 3 años sin motivo.
- No derivar lesiones de alto grado.
- Interpretar “VPH positivo” como cáncer.
- Olvidar seguimiento post-tratamiento de HSIL.
- No registrar resultados en programa de pesquisa.

13. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El **Papanicolaou** y el **test de VPH** son pilares en la prevención del cáncer cervicouterino.
2. El **PAP se inicia a los 25 años** y se repite **cada 3 años** si es normal.
3. El **test de VPH** se recomienda desde los 30 años, cada 5 años si negativo.
4. **LSIL / HSIL** → **colposcopía y biopsia**.

5. El **co-test (PAP + VPH)** aumenta la sensibilidad y amplía el intervalo de control.
6. Toda mujer con **citología anormal debe tener seguimiento documentado.**
7. La detección precoz reduce drásticamente la mortalidad por cáncer cervicouterino.